

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073904-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO
RECORRENTE: ALCINEA NOVAES FREIRE MARIANO
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA NO ENCÉFALO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO ENTRE HOSPITAIS IMPEDINDO INÍCIO DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA IMEDIATA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DILIGÊNCIAS ENTRE UNIDADES DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, deferindo a tutela provisória de urgência para determinar que os Réus realizem as diligências administrativas necessárias para propiciar a continuidade do tratamento oncológico da paciente, com encaminhamento, se for o caso, a outro hospital especializado em oncologia. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5073904-56.2024.4.02.5101

510014666338 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073904-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO
RECORRENTE: ALCINEA NOVAES FREIRE MARIANO
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO
RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 4, DESPADEC1 que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus procedam a transferência da autora, preferencialmente, para o INCA a fim de que seja dada continuidade ao seu tratamento oncológico.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser portadora de neoplasia maligna do encéfalo de Grau IV, já tendo realizado cirurgia neurológica com posterior encaminhamento ao Hospital Antônio Pedro. Contudo, informa que o referido nosocômio não realizou o tratamento necessário ao controle da doença, exigindo a apresentação de lâmina de exame, que não pôde ser apresentada, pois a retirada do material foi realizada junto ao Hospital Miguel Couto, por meio de empresa terceirizada.

Assim, aduz não ter conseguido o tratamento médico necessário ao controle de sua doença, o que acarretou o aparecimento de novo tumor cerebral, demandando nova cirurgia, que dessa vez, foi realizada no Hospital Miguel Couto, para a retirada do tumor.

Sustenta necessitar dar continuidade ao tratamento oncológico com urgência, porém, o Hospital Antônio Pedro vem negando o atendimento acarretando a piora no quadro clínico, razão pela qual objetiva o encaminhamento a outro hospital, de preferência o INCA.

Contrarrazões em evento 41, PET1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de elementos aptos a modificar a decisão monocrática de evento 14, colaciono seus fundamentos através do presente voto, reforçando a responsabilidade solidária dos Réus para propiciarem a continuidade do tratamento oncológico da paciente:

"Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfuntório, o laudo médico de evento 1, ANEXO3, fls. 10 informa que a autora é portadora de neoplasia maligna no encéfalo de grau IV, já tendo sido submetida à duas cirurgias neurológicas, necessitando, no presente momento, dar continuidade ao tratamento oncológico através de sessões de radioterapia.

*O parecer do NAT de evento 9, PARECER1, corrobora as informações médicas acerca da gravidade do quadro clínico, acrescentando que a autora está sendo atualmente assistida por unidade de saúde do SUS habilitada na Rede de Alta Complexidade Oncológica, a saber, o Hospital Universitário Antônio Pedro. Contudo, **o tratamento com radioterapia ainda não se iniciou, pois o referido nosocômio está exigindo a lâmina do exame que, segundo a paciente, foi realizado pelo Hospital Municipal Miguel Couto, através de empresa terceirizada.***

*Desse modo, embora a via administrativa esteja sendo utilizada, o caso da autora encontra-se sem solução, necessitando de diligências a serem cumpridas entre o hospital federal que acompanha a paciente e o hospital municipal que realizou os exames e a segunda cirurgia. Logo, reputo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a impossibilidade de a autora aguardar uma decisão em cognição exauriente, já que os documentos médicos e o parecer do NAT são categóricos ao informar a urgência do tratamento **sob pena de nova recidiva da doença que poderá ser irreversível.***

Assim, deve o Hospital Antônio Pedro diligenciar junto ao Miguel Couto a fim de providenciar todos os procedimentos necessários para o tratamento oncológico complementar da autora através de sessões de radioterapia, seja perante o próprio HUAP ou, caso necessário, com encaminhamento a outro hospital que também tenha especialidade em oncologia.

Pois bem. Como visto, o laudo médico acostado aos autos originários (evento 1, ANEXO3) informa que a autora é portadora de **neoplasia maligna no encéfalo, grau IV**, já tendo passado por duas cirurgias neurológicas e necessitando de tratamento radioterápico urgente para evitar recidiva irreversível, situação ratificada pelo parecer do NAT.

Logo, a demora na realização das diligências administrativas entre os hospitais está impedindo o acesso à paciente ao tratamento essencial à preservação de sua vida.

Além disso, a exigência de um exame por parte do HUAP, realizado no Hospital Municipal Miguel Couto por empresa terceirizada, revela uma ineficiência no trâmite administrativo entre as unidades de saúde, que não pode ser imputada à paciente. A responsabilidade pela troca de informações e pela obtenção dos documentos necessários ao tratamento é das próprias instituições envolvidas, sendo ilegítimo que a paciente, já em situação de extrema vulnerabilidade, seja prejudicada por tais falhas.

Dessa forma, para garantir o direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/1988) e a continuidade do tratamento oncológico, é legítima a intervenção judicial que determina às unidades de saúde que promovam as diligências necessárias, de modo a assegurar o início imediato das sessões de radioterapia, seja no próprio Hospital Universitário Antônio Pedro, seja em outra unidade da Rede de Alta Complexidade Oncológica, caso necessário.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso, deferindo a tutela provisória de urgência para determinar que os Réus realizem as diligências administrativas necessárias para propiciar a continuidade do tratamento oncológico da paciente, com encaminhamento, se for o caso, a outro hospital especializado em oncologia. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.